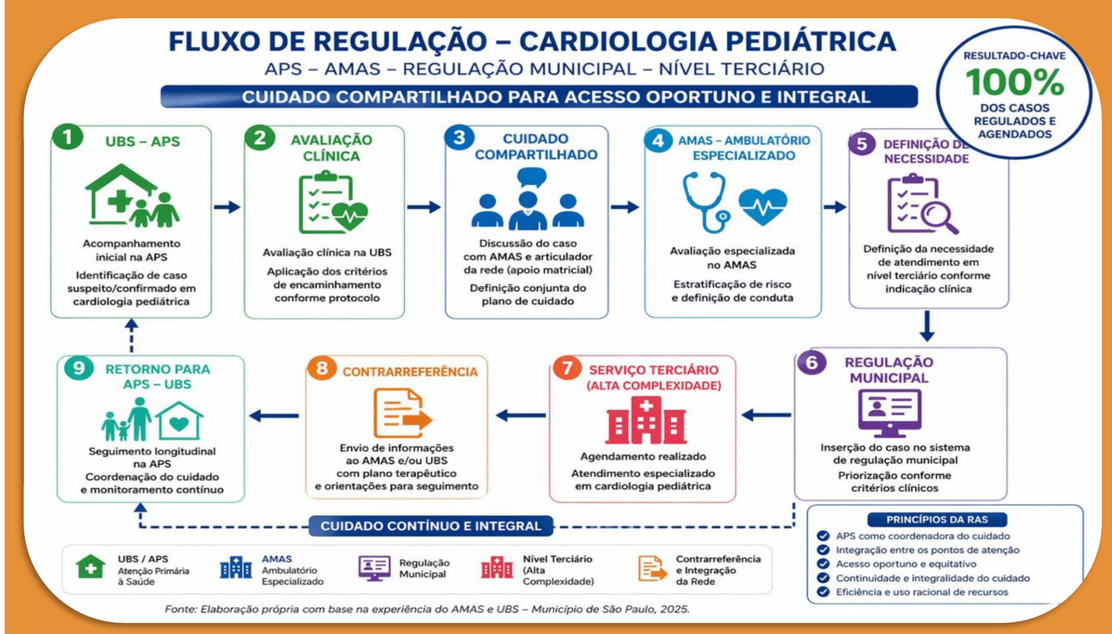
2º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAGEM DE FAMÍLIA E COMUNIDADE
2º CONGRESSO ALAGOANO DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE

Estratégia Saúde da Família: a potência brasileira que inspira o mundo
30 de abril a 2 de maio de 2026
MACEIÓ • ALAGOAS

Realização
ABEFACO
AAMFC

COORDENAÇÃO DO CUIDADO E REGULAÇÃO DO ACESSO AO NÍVEL TERCIÁRIO EM CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA NA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE: EXPERIÊNCIA EM SÃO PAULO.

AUTORES: Demetrio José Cleto Enfermiero; Cristien Latanzi Assistente Social.



PRINCIPAIS ACHADOS

- 25 casos pediátricos regulados em cardiologia
- 21 UBS envolvidas
- **100% de acesso ao nível terciário**
- Fortalecimento da APS como coordenadora do cuidado
- Redução da fragmentação assistencial

Introdução

O acesso à cardiologia pediátrica em nível terciário no SUS ainda é marcado por filas e fragmentação do cuidado. A organização das Redes de Atenção à Saúde, com a APS como coordenadora, é essencial para garantir acesso oportuno e integral. Em São Paulo, a articulação entre o ambulatório AMAS e as UBS estruturou uma estratégia de qualificação da regulação, promovendo continuidade e integração do cuidado.

Objetivo

- Descrever a experiência de regulação ao nível terciário
- Organizar fluxos assistenciais e critérios clínicos
- Garantir acesso oportuno e integral
- Fortalecer a coordenação do cuidado no SUS

Métodos

Relato de experiência iniciado em janeiro de 2025 no município de São Paulo, envolvendo equipes da APS, profissionais do ambulatório AMAS, articulado de Redes de Atenção à Saúde e gestores locais.. Principais métodos utilizados:

Protocolos clínicos, Fluxos pactuados, Apoio matricial, Contrarreferência por POP.

O articulador da rede atuou na integração entre serviços e acompanhamento dos casos.

A partir desses dispositivos, foram identificados e acompanhados casos pediátricos de cardiologia com indicação de atenção em nível terciário, organizando o acesso por meio da regulação municipal.

Resultados

25 casos pediátricos compartilhados

21 UBS envolvidas

100% dos casos regulados e agendados

Impactos

Qualificação do manejo clínico na APS

Maior segurança das equipes

Continuidade do cuidado fortalecida

Redução de incertezas para famílias

Maior eficiência da rede municipal

Conclusão/Considerações finais

A regulação estruturada, baseada no cuidado compartilhado entre APS e AMAS, mostrou-se eficaz para garantir integralidade, equidade e continuidade do cuidado.

O alcance de **100% de acesso** reforça o potencial de replicação da estratégia em outras linhas de cuidado

INSTITUIÇÃO: AMAS UMANE – IRSSL
AUTOR: Demétrio José Cleto
Enfermeiro

E-mail:demetrio.jcleto@irssl.org.br
Contatos: 11 52001130
Website:

INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SÍRIO-LIBANÊS
UMANE